



AMSTC

Association Médico-Sociale
des Talibés Cheikh

RECOMMANDATIONS 2025 – 2026

HTA : Signes, Diagnostic & Prise en Charge

Dr Papa Mouhamadou Diarra Fall

Ancien interne des hôpitaux
Cardiologue à l'Hôpital de La Paix de Ziguinchor

Wébinaire du 20 septembre 2026

Définition

TUEUR SILENCIEUX

Définition Clinique

L'Hypertension Artérielle (HTA) est une élévation chronique de la pression artérielle entraînant des contraintes mécaniques vasculaires.

C'est un **facteur de risque cardiovasculaire majeur**, responsable de lésions progressives et irréversibles sur les organes cibles (cœur, cerveau, reins, yeux).

Épidémiologie & Impact Mondial

DONNÉES OMS / ESC

1.28 B

Adultes touchés

Prévalence mondiale de 30% à 45%
chez l'adulte

50%

Ignorent leur état

1 patient sur 2 non diagnostiqué
("tueur silencieux")

< 20%

Patients contrôlés

Seule une minorité atteint les cibles
thérapeutiques

10 M

Décès / an

Première cause de mortalité
cardiovasculaire globale

Évolution récente : Les 2/3 des patients hypertendus vivent aujourd'hui dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Le vieillissement et l'obésité accélèrent cette progression.

Symptômes

Une Pathologie Silencieuse

L'HTA est asymptomatique dans 90% des cas pendant de nombreuses années.
L'organisme s'adapte progressivement aux élévations tensionnelles.

Les dégâts vasculaires et tissulaires s'accumulent à bas bruit sans éveiller l'attention du patient.

"L'absence de symptôme n'est en aucun cas une preuve de santé vasculaire."



Seuils Diagnostic & Classification

ESC 2024 VS ACC/AHA

Catégorie / Méthode	ESC 2024 (Europe)	ACC/AHA (USA)	Signification Clinique
PA Consultation (Cabinet)	≥ 140 / 90 mmHg	≥ 130 / 80 mmHg	Confirmation requise hors cabinet
PA Élevée (Nouvelle)	130-139 / 80-89 mmHg	120-129 / <80 mmHg	Évaluer le risque SCORE2
MAPA - Moyenne 24h	≥ 130 / 80 mmHg	≥ 125 / 75 mmHg	Reflet le plus fidèle du risque CV
MAPA - Diurne / Automesure	≥ 135 / 85 mmHg	≥ 130 / 80 mmHg	Moyenne sur 7 jours (AMT)
MAPA - Nocturne	≥ 120 / 70 mmHg	≥ 110 / 65 mmHg	Détection du profil Non-Dipper

Confirmation Diagnostic : MAPA & AMT

GOLD STANDARD

MAPA 24h (Gold Standard)

- ✓ Mesures automatiques toutes les 15-20 min (jour) et 30 min (nuit).
- ✓ Élimine l'effet « Blouse Blanche » (présent dans 30% des cas).
- ✓ Déchiffre le profil nocturne (Non-Dipper / Riser).
- ✓ Normes américaines : Normales : 24h < 125/75, Diurne < 130/80, Nocturne < 110/65 mmHg.

Automesure Tensionnelle (AMT)

Règle des 3 : 3 mesures le matin, 3 mesures le soir pendant 7 jours consécutifs. Seuil d'HTA : $\geq 135/85$ mmHg.



Les 4 Profils Tensionnels Cliniques

1. HTA Blouse Blanche

Cabinet : Élevée ($\geq 140/90$) | **MAPA/AMT :** Normale

Liée à l'anxiété de la consultation. En général, pas de traitement médicamenteux sauf si très haut risque CV, mais surveillance rigoureuse.

2. HTA Masquée

Cabinet : Normale ($< 140/90$) | **MAPA/AMT :** Élevée

Risque cardiovasculaire aussi élevé que l'HTA permanente. Dépistage actif recommandé chez les sujets à haut risque ou diabétiques.

3. HTA Sévère / Persistante

Cabinet : Élevée | **MAPA/AMT :** Élevée

HTA vraie confirmée. Nécessite une prise en charge pharmacologique immédiate et un bilan de retentissement d'organe.

4. HTA Nocturne (Non-Dipper)

Consultation : Variable | **Nuit :** Absence de baisse $> 10\%$

Fortement associée au syndrome d'apnée du sommeil (SAOS), à l'insuffisance rénale et au diabète. Reclasse le patient en très haut risque.

Examen Clinique : Quoi Rechercher ?

Type d'Examen	Signes à Rechercher	Orientation / Signification
Signes Fonctionnels (Rares & non spécifiques)	• Céphalées occipitales matinales	Poussée tensionnelle ou HTA sévère.
	• Vertiges / Acouphènes / Épistaxis	Fatigue fréquente mais banale.
	• Asymétrie tensionnelle (>10 mmHg)	Sténose sous-clavière
Signes Physiques (Examen systématique)	• Baisse des pouls fémoraux	Coarctation aortique
	• Souffle abdominal / carotidien	Sténose artère rénale / Athérome
Lésions d'Organes (Bilan initial)	• Rétinopathie au Fond d'œil	Souffrance micro/macro-vasculaire
	• HVG à l'ECG / Bruit B3-B4	Retentissement cardiaque de l'HTA

Évaluation du Risque CV : SCORE2

ESC 2024

Stratification SCORE2 / SCORE2-OP

La décision d'initier un traitement pour une PA Élevée (130-139/80-89) repose sur le risque cardiovasculaire global à 10 ans.

📈 SCORE2 : Évalue le risque chez les sujets âgés de 40 à 69 ans.

📈 SCORE2-OP : Dédié aux sujets âgés de ≥ 70 ans.

📊 Variables : Âge, sexe, statut tabagique, PAS, Cholestérol non-HDL.

Seuils de Risque & Conduite :

Risque Faible $< 5\%$: Hygiène de vie seule.

Risque Modéré 5 - 10% : Hygiène de vie 3 mois, réévaluation.

Risque Élevé $\geq 10\%$: Traitement médicamenteux si PA $\geq 130/80$ mmHg.

Parcours Décisionnel Thérapetique

ALGORITHME ESC 2024

Dépistage

PA consultation $\geq 140/90$
ou 130-139/80-89 mmHg.

Confirmation

MAPA 24h ou Automesure
(AMT) 7 jours.

Initiation

HTA : Bithérapie SPC
d'emblée.

PA élevée : RHD + Drug si
SCORE2 $\geq 10\%$.

Titration

Si PAS ≥ 130 à 1 mois →
Trithérapie SPC →
Spironolactone si résistante.

Urgences Hypertensives

STRATIFICATION & URGENCE

Critère	Poussée Hypertensive Simple	Urgence Hypertensive Maligne (Emergency)
Niveau de PA	≥ 180 / 120 mmHg	≥ 180 / 120 mmHg
Atteinte Organe Cible	ABSENTE	PRÉSENTE (Aiguë & Menaçante)
Signes Cliniques	Céphalées modérées, anxiété, vertiges	AVC, OAP, Dissection aortique, Encephalopathie, SCA
Lieu de Soins	Ambulatoire (Consultation)	Hospitalisation en Soins Intensifs (USIC)
Objectif Thérapeutique	Réduction progressive sur 24-48h (Voie orale)	↓ PAS de 20-25% la 1ère heure (Voie IV : Nicardipine, Urapidil)

Mesures Hygiéno-Diététiques

-  **Réduction sodée** : < 5 g/jour de sel (-5 à -10 mmHg sur la PAS).
-  **Régime DASH** : Riche en légumes, fruits et céréales (-8 à -14 mmHg).
-  **Activité physique** : 150 min/semaine d'effort modéré (-5 à -8 mmHg).
-  **Contrôle pondéral** : -1 mmHg par kg perdu.
-  **Modération d'alcool & Tabac** : Sevrage tabagique impératif.

Nouveauté 2025 : Utilisation recommandée de substituts de sel enrichis en Potassium (prudence si insuffisance rénale).



Escalade Thérapeutique Structurée



HTA Résistante & Hyperaldostéronisme

DÉPISTAGE ÉLARGI 2025

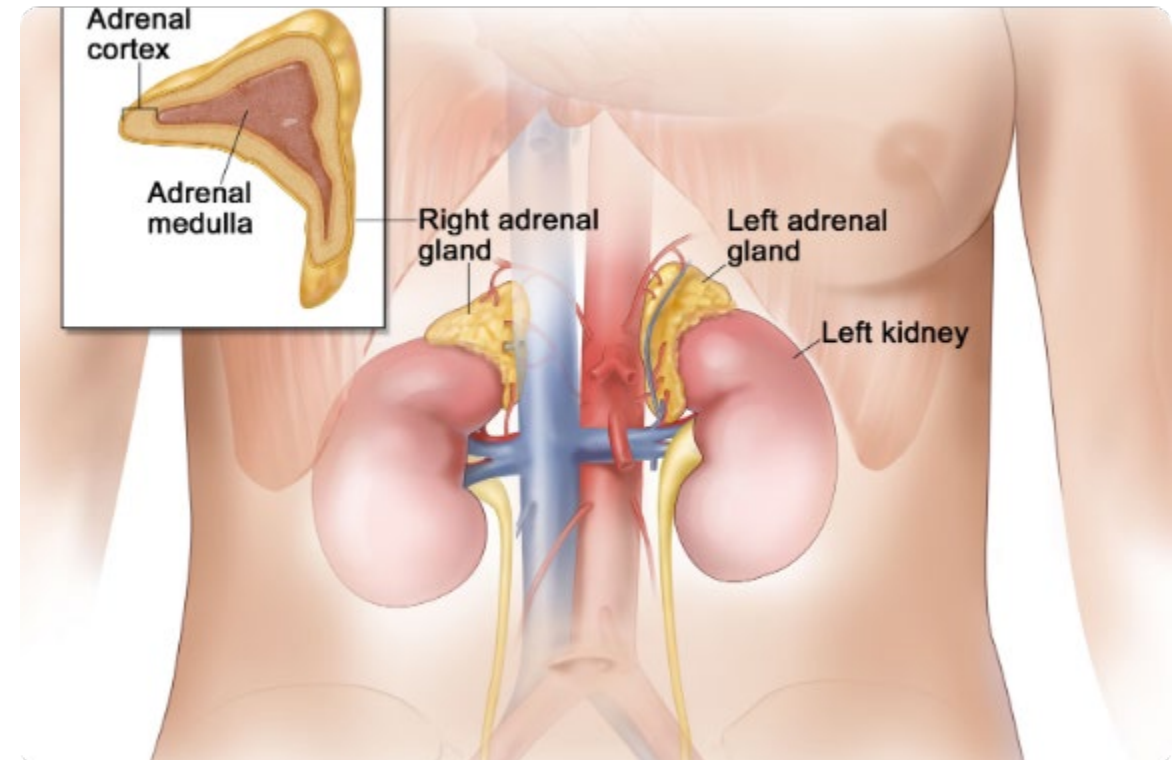
Stratégie Diagnostic 2025

Définition : PA > 130/80 sous trithérapie optimale incluant un diurétique.

Dépistage Élargi : Dépister l'**Hyperaldostéronisme Primaire (HAP)** chez :

- Tous les patients en HTA Stade 2 ($\geq 140/90$) (Nouveau)
- Toutes les HTA résistantes (jusqu'à 20% de causes HAP)

Test : Rapport Aldostérone / Rénine (ARR).



Dénervation Rénale

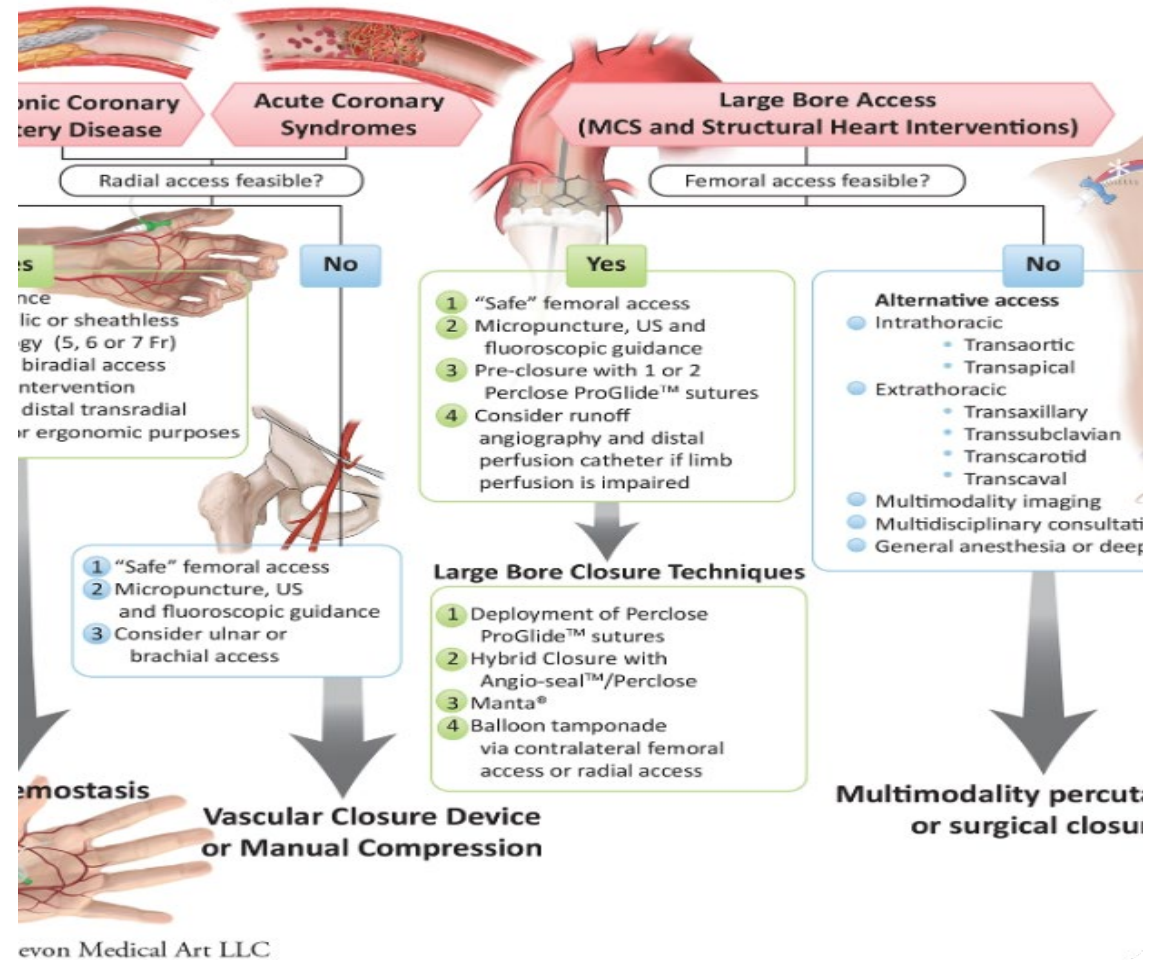
CLASSE IIB (2025)

Technique d'endonavigation percutanée réduisant le tonus sympathique rénal hyperactif.

Indications ciblées : HTA résistante confirmée par MAPA, après exclusion des causes secondaires et confirmation de la bonne observance médicamenteuse.

Efficacité : Réduction moyenne de 6 à 10 mmHg de la PAS à 6 mois.

Contemporary Arterial Access and Closure in the Cardiac Catheterization Labo



L'Observance : Le Levier Majeur

50%

d'abandon à 1 an

< 30% d'observance stricte à 5 ans

Solutions de Terrain 2025

-  Privilégier les combinaisons fixes (SPC) : 1 seule prise quotidienne.
-  Éducation thérapeutique (ETP) : Impliquer le patient.
-  Automesure tensionnelle : Suivi actif du patient chez lui.

Prise en Charge : Cas Particuliers

ADAPTATIONS

Population / Pathologie	Cible Tensionnelle	Stratégie Thérapeutique Spécifique
Sujet Âgé (≥ 80 ans)	PAS 130 - 139 mmHg	Monothérapie initiale progressive. Surveiller la PA orthostatique.
Diabète de Type 2	< 130 / 80 mmHg	IECA / ARA2 prioritaires (Néphroprotection) + BCC.
Insuffisance Rénale (DFG < 30)	< 130 / 80 mmHg	Préférer les diurétiques de l'anse (Furosémide) aux thiazidiques.
Insuffisance Cardiaque	< 130 / 80 mmHg	IECA/ARA2 + Bêta-bloquant + MRA + SGLT2i. (Contre-indication BCC non-DHP).
Post-AVC / AIT	< 130 / 80 mmHg	Association IECA + Indapamide ou BCC à privilégier.

Synthèse des Messages Clés

ESC 2024

- ✓ **Diagnostic** : HTA si PA consultation $\geq 140/90$ mmHg, **confirmation obligatoire par MAPA/AMT**.
- ✓ **Nouveauté "PA Élevée"** : 130-139 / 80-89 mmHg. Traiter si SCORE2 $\geq 10\%$.
- ✓ **Cible unifiée** : Viser PAS < 130 mmHg (120-129 si toléré) pour tous les patients.
- ✓ **Traitement initial** : Bithérapie d'emblée en combinaison fixe (SPC) **IECA/ARA2 + BCC**.
- ✓ **HTA Résistante** : Ajouter Spironolactone 25mg, dépister l'HAP, discuter la dénervation rénale (IIb).



Catégorie "PA Élevée"

Création du seuil **130-139 / 80-89 mmHg**. Prise en charge médicamenteuse si le risque CV à 10 ans est $\geq 10\%$ (SCORE2).



Cible Tensionnelle Unifiée

Objectif PAS **< 130 mmHg** pour la majorité des patients (120-129 mmHg si bien toléré). Alignement sur l'essai SPRINT/ESPRIT.



Bithérapie SPC d'Emblée

Combinaison fixe **IECA/ARA2 + BCC** en 1^{er} choix (1 seule pilule) pour maximiser l'observance dès l'initiation.



Dénervation Rénale

Gradée en **Classe IIb** pour l'HTA résistante confirmée par MAPA dans un centre d'expertise multidisciplinaire.

Merci de votre attention !

Avez-vous des questions sur les nouvelles recommandations ESC 2024
?

Dr Papa Mouhamadou Diarra Fall

Actualisation Clinique & Thérapeutique de l'Hypertension
Artérielle

Image Sources



<https://www.frontiersin.org/files/Articles/1205475/xml-images/fcvm-10-1205475-g001.webp>

Source: www.frontiersin.org



<https://assets.heartfoundation.org.nz/images/heart-healthcare/heart-tests/heart-tests-24-hour-blood-pressure-monitor-ambulatory-blood-pressure-monitor.webp?mtime=1765145119>

Source: www.heartfoundation.org.nz



https://cdn.prod.website-files.com/6426543485efe6a5ade36f21/64ab6014304942f119d5868f_REC003_Still_04.jpg

Source: www.ghostmedical.com